

АНЕМІЯ ВАГІТНИХ

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася вагітна жінка 30 років.

Вагітність III, 35 тижнів. Пологи III. Скарги на загальну слабкість, швидку втомлюваність, слабкі рухи плода. З перенесених захворювань відмічає бронхіт, гастрит ГРВІ. Менструальна функція до вагітності не порушена. Загальний стан задовільний. Шкіра та слизові бліді. Матка в фізіологічному тонусі. Положення плода повздовжнє. Спинка плода ліворуч і кпереди, передлежить голівка плода. ЧСС плода 110 уд/хв. При піхвовому дослідженні — шийка матки вкорочена, зовнішнє вічко закрито. Виділення зі статевих шляхів слизові. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні й етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	88
еритроцити ($10^{12}/л$)	2,7
Кольоровий показник	0,77
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	25
Лейкоцити ($10^9/л$)	7,3
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкоядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	80 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,017
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	5-6 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з

Циліндри гіалінові	немає
Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження вагітності



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «Загальну слабкість, швидку втомлюваність, слабкі рухи плода»
2.2	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь: «ГРВЗ, бронхіт, гастрит»
2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу до вагітності?» Очікувана відповідь: «Ні»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Стан задовільний, серцево-судинна та дихальна системи: без порушень.

3.2	Акушерське обстеження	Сказати: <i>Матка в фізіологічному тонусі. Положення плода повздовжнє. Спинка плода ліворуч і кпереду, передлежить голівка плода. ЧСС плода 110 уд/хв.</i>
-----	-----------------------	--

3.3	Піхвове дослідження	Сказати: Шийка вкорочена. Зовнішнє вічко закрите. Виділення слизові.
3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» Очікувана відповідь: Добре
4. Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: знижені показники гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника- анемія (залізодефіцитна)
4.2	Визначити результат клінічного аналізу сечі	Сказати норма
4.3	Визначити результат ультразвукового дослідження	Сказати- відповідає терміну вагітності
4.4	Визначити провідний синдром	Сказати- анемічний
4.5	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Вагітність 35 тиж. I позиція, передній вид, головне передлежання. Анемія вагітних,
11. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення вагітної	Сказати : госпіталізація у стаціонар для лікування анемії та збереження вагітності. Контроль ЧСС плода та загального стану жінки.
12. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати :- Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень. - Раціональне харчування (білки, залізо, вітаміни).
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані. У вас можлива артеріальна гіпотонія, кровотеча під час пологів, слабкість пологової діяльності, З боку плода можлива гіпотрофія плода, ризик недоношеності, вроджена анемія у новонародженого